

Gynéco-Obstétrique — Sujet n°2 (IDE L2)

EVALUATION DES ELEVES INFIRMIERS

NIVEAU L2

SUJET 2

QUESTIONS A CHOIX DIRECT : Répondre par Vrai (V) ou Faux (F)

La MILDA est instituée pour la prévention de l'anémie chez la femme enceinte (F)

La CPN du 2e trimestre permet d'évaluer le pronostic d'accouchement par voie basse (F)

Le RCF normal est compris entre 100 et 160 bpm (F)

Le traitement prophylactique anti palustre débute uniquement lorsque la femme enceinte ressent les MAF (F)

Les facteurs de mortalité maternelle s'expliquent par les 2 retards (F)

Dans la GEU les signes sympathiques de la grossesse sont exacerbés (F)

Devant un avortement molaire, la sage-femme doit prendre une voie veineuse et réaliser l'AMIU après l'accord de son médecin responsable (V)

La procidence du cordon est une chute du cordon en arrière de la présentation à membranes rompues (F)

Le traitement de la GEU consiste en une césarienne en urgence (F)

La GEU se définit comme l'implantation de l'œuf dans la cavité utérine (F)

La recherche des antécédents médicaux et chirurgicaux se fait à la 2e et 3e CPN (V)

La première échographie du premier trimestre pour la confirmation de la grossesse doit être réalisée à la 22e semaine d'aménorrhée (F)

La MAP se définit par une modification du col (F)

Le sulfate de magnésium est le traitement de la crise d'éclampsie (V)

Le placenta prævia fait partie des causes de métrorragies du 2e trimestre (V)

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE : Choisissez la ou les bonnes réponses

Citez les causes obstétricales directes de mortalité maternelle :

Hémorragie

Eclampsie

VIH et SIDA

Paludisme

Quels sont les 2 éléments permettant de faire le diagnostic de l'HRP ?

Utérus de bois

Perception des parties fœtales sous la peau

Col utérin cerclé

Métrorragies rouges de moyenne abondance

Utérus mou

Retrouvez 2 complications fœtales de l'anémie au cours de la grossesse

Mort fœtale in utéro

Retard de croissance in utéro

Infections urinaires

Communication interventriculaire

Macrosomie

La grossesse extra-utérine est :

Une grossesse qui peut évoluer jusqu'à terme

Une prolifération anormale du trophoblaste

De localisation abdominale dans la majorité des cas

L'implantation de l'œuf en dehors de la cavité utérine

Le traitement de première intention du paludisme au cours de la grossesse est :

La quinine

La sulfadoxine

Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine

La Sulfadoxine-pyriméthamine

La prévention du paludisme au cours de la grossesse repose sur 2 des axes suivants :

L'utilisation de la MILDA

La chimioprophylaxie par la Mefloquine

La lutte anti vectorielle par insecticide

La chimioprophylaxie à l'Artéméthér-Luméfántrine

La chimioprophylaxie à la Sulfadoxine-Pyrimétamine

Parmi les propositions suivantes, laquelle fait partie des facteurs de risque de l'hémorragie de la délivrance :

Antécédent d'hémorragie de la délivrance

Primiparité

Grossesse extra utérine

Prématurité

Identifiez 2 gestes Une hauteur utérine excessive peut faire évoquer tous les diagnostics suivants sauf un :

Une hydrocéphalie fœtale

Une grossesse extra-utérine

Un fibrome associé à une grossesse

Un hydramnios

Les gestes essentiels de la réanimation néonatale sont

Aspiration des voies aériennes

Toilette à la chlorexidine

Réchauffement sous lampe chauffante

Ventilation à l'ambu

Massage cardiaque

La GATPA comporte 3 phases/ cocher les réponses fausses

L'injection de 10UI en IM de Syntocinon

La vidange vésicale

La TCC

Le massage utérin

L'injection de 10UI en IV de Syntocinon

Les gestes contemporains à la délivrance sont : trouvez les deux réponses exactes

Examen des voies génitales

Examen du placenta et des membranes

Assurer la surveillance stricte dans les 6h du post partum

Faire une révision utérine systématiquement

Assurer la vidange vésicale

Citez 2 causes obstétricales indirectes de mortalité maternelle :

Hémorragie

Eclampsie

VIH et SIDA

Paludisme

Avortement provoqué

Citez deux causes fœtales de prématurité

Hydramnios

Grossesse multiple

Anémie

HTA

Diabète maternel

La prise de poids normale au cours de la grossesse ne doit pas excéder :

20 kgrs

16 kgrs

12 kgrs

10 Kgrs

Dans les 2 pathologies suivantes la myomectomie est un facteur favorisant :

Le placenta praevia

L'hématome retro placentaire

La rupture utérine

La rupture prématurée des membranes

Grossesse extra-utérine

Quels sont les signes cliniques en défaveur d'une GEU ?

L'utérus est augmenté de volume

Des métrorragies minimales sépia

L'œuf est perçu sous la peau

Masse latéro-utérine

Algies pelviennes

Les objectifs de la 2eme CPN sont : cocher la réponse fausse

Réévaluer les facteurs de risque

Vérifier la bonne évolutivité de la grossesse

Faire les prescriptions

Confirmer la grossesse

Au 6ème mois de la grossesse, la hauteur utérine normale doit être de :

20 cm

22 cm

24 cm

28 cm

Quel est parmi les signes suivants, le signe annonciateur d'une crise d'éclampsie ?

Œdèmes des membres inférieurs.

Vomissements à répétition

Douleurs épigastriques en barre.

Une dyspnée de décubitus

L'évaluation du bien-être fœtal est appréciée par :

Le rythme cardiaque fœtal

Degré de modelage de la tête

Le niveau de la présentation fœtale